



**โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ**

1. ชื่อโครงการ : โครงการเฝ้าระวังภาวะสมองเสื่อมแบบมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน
2. หน่วยงานที่ดำเนินการ : สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกสาธาณสุขศาสตร์ และเอกการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
3. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Action Plan) มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)

ประเด็นยุทธศาสตร์

- ☒ 1. พัฒนาชุมชนท้องถิ่น
- ☐ 2. ผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพ
- ☐ 3. ยกระดับคุณภาพการศึกษา
- ☐ 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการ

4. ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2569)

พันธกิจ	ประเด็นยุทธศาสตร์
☐ 1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน ☐ 2. วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน ☒ 3. ให้บริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริเพื่อความเข้มแข็งของท้องถิ่น ☐ 4. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริม สืบสาน และสร้างคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ☐ 5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครูบุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรในสาขาวิชาชีพอื่น ๆ ☐ 6. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล	☒ 1. พัฒนาชุมชนท้องถิ่น ☐ 2. ผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพ ☐ 3. ยกระดับคุณภาพการศึกษา ☐ 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการ



5. หลักการและเหตุผล

ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ส่งผลให้สัดส่วนประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพเรื้อรังหลายประการ โดยเฉพาะภาวะสมองเสื่อม ซึ่งจัดเป็นปัญหาสาธารณสุขที่มีความสำคัญและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ภาวะสมองเสื่อมส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทำหน้าที่ทางสติปัญญา การดำเนินชีวิตประจำวัน ความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ตลอดจนคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย ครอบครัว และผู้ดูแล อีกทั้งยังก่อให้เกิดภาระทางเศรษฐกิจและสังคมในระยะยาว ทั้งในระดับครัวเรือน ชุมชน และระบบบริการสาธารณสุขของประเทศ จากหลักฐานทางวิชาการพบว่า ภาวะสมองเสื่อมเป็นภาวะที่มีปัจจัยเสี่ยงหลายด้าน ทั้งปัจจัยที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เช่น อายุ และพันธุกรรม รวมถึงปัจจัยที่สามารถป้องกันหรือปรับเปลี่ยนได้ เช่น โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อาทิ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง รวมถึงพฤติกรรม การดำเนินชีวิตที่ไม่เหมาะสม การขาดการกระตุ้นการทำงานของสมอง การมีกิจกรรมทางกายที่ไม่เพียงพอ ความโดดเดี่ยวทางสังคม และภาวะซึมเศร้า ซึ่งปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้มีความสัมพันธ์กับการเสื่อมถอยของการทำงานของสมองและการเกิดภาวะสมองเสื่อมในระยะยาว

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ มีบทบาทสำคัญในการผลิตบัณฑิตและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการพัฒนาสุขภาพชุมชน โดยเน้นทักษะวิศวกรสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการ พัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน และการใช้ข้อมูลทางด้านสุขภาพเชิงประจักษ์ในการวางแผนและดำเนินงาน การนำองค์ความรู้และศักยภาพของคณาจารย์และนักศึกษา สาขาสาธารณสุขศาสตร์มาบูรณาการในการดำเนินโครงการ จะช่วยเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง และตอบสนองต่อความต้องการด้านสุขภาพของชุมชนได้อย่างเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับโครงการพัฒนาท้องถิ่นระดับสาขาแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น หลักฐานทางวิชาการด้านสาธารณสุขศาสตร์พบว่าภาวะสมองเสื่อมมีความสัมพันธ์กับปัจจัยกำหนดสุขภาพหลายด้าน ทั้งปัจจัยส่วนบุคคล พฤติกรรมสุขภาพ ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม และบริบททางสังคม โดยเฉพาะโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง การขาดกิจกรรมกระตุ้นการทำงานของสมอง การมีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ การขาดการมีส่วนร่วมทางสังคม และการเข้าถึงบริการส่งเสริมสุขภาพที่ยังไม่ครอบคลุม ซึ่งปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้สามารถลดลงได้ด้วยการดำเนินงานเชิงป้องกันในระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ จึงสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2569

ดังนั้นพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาฝายกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับวัยสูงอายุ โดยเฉพาะภาวะสมองเสื่อม มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ภาวะสมองเสื่อมส่งผลกระทบต่อความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวัน การพึ่งพาตนเอง คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ตลอดจนก่อให้เกิดภาระต่อครอบครัว ชุมชน และผู้ดูแล การครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลระยะยาว จึงนับเป็นปัญหาสาธารณสุขที่จำเป็นต้องได้รับการป้องกันและแก้ไขอย่างเป็นระบบและเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไข เพื่อให้เกิดความยั่งยืนทางด้านสุขภาพเชิงระบบ



Che

6. วัตถุประสงค์ (Objectives) ผลลัพธ์หลัก (OKRs) และคำเป้าหมาย

วัตถุประสงค์ (Objectives)	ผลลัพธ์หลัก (Key results)	คำเป้าหมาย
1. กิจกรรมคัดกรองและประเมินความเสี่ยงภาวะสมองเสื่อมในชุมชนร่วมกับทักษะวิศวกรสังคม		
1.1 เพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการด้านการคัดกรองและประเมินสุขภาพในชุมชนให้แก่นักศึกษาสาขาสาธารณสุขศาสตร์ ผ่านการดำเนินงานจริงร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่	1.1 นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะด้านการคัดกรองและประเมินสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	1.1 นักศึกษาสาขาสาธารณสุขศาสตร์มีทักษะด้านการคัดกรองและประเมินสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนทางเพิ่มขึ้น ร้อยละ 80
1.2 เพื่อคัดกรองสมรรถภาพการทำงานของสมองและประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะสมองเสื่อมในประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชน	1.2 ผู้สูงอายุในชุมชนได้รับการคัดกรองสมรรถภาพการทำงานของสมองและประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุในชุมชนโดยการใช้เครื่องมือ MMSE (Mini-Mental State Examination) และ Mini-Cog	1.2 ผู้สูงอายุในชุมชนได้รับการคัดกรองสมรรถภาพการทำงานของสมองและประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะสมองเสื่อม ร้อยละ 80
2. กิจกรรมอบรมความรู้รอบเรื่องการดูแลสุขภาพสมองและการป้องกันภาวะสมองเสื่อมในชุมชน		
2.1 เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการทำงานของสมอง ภาวะสมองเสื่อม ปัจจัยเสี่ยง และแนวทางการป้องกันภาวะสมองเสื่อมแก่นักศึกษาสาขาสาธารณสุขศาสตร์	2.1 นักศึกษาได้รับองค์ความรู้ ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการทำงานของสมอง ภาวะสมองเสื่อม ปัจจัยเสี่ยง และแนวทางการป้องกันภาวะสมองเสื่อมอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนำไปต่อพัฒนาการมีภาวะผู้นำเพื่อนำไปต่อพัฒนาการมีภาวะผู้นำทางด้านสุขภาพ (Health Leader)	2.1 นักศึกษามีองค์ความรู้เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการทำงานของสมองร่วมกับปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดภาวะสมองเสื่อม ร้อยละ 80
2.2 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการทำงานของสมอง ภาวะสมองเสื่อม ปัจจัยเสี่ยง และแนวทางการป้องกันภาวะสมองเสื่อมแก่ประชาชนในชุมชน	2.2 ผู้สูงอายุในชุมชนได้รับความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการทำงานของสมอง ภาวะสมองเสื่อม ปัจจัยเสี่ยง และแนวทางการป้องกันภาวะสมองเสื่อม และสามารถพัฒนาเป็นแกนนำทางด้านสุขภาพ (Health Advocate)	2.2 นักศึกษาสามารถเป็นผู้นำทางด้านสุขภาพ ด้านการสื่อสารและถ่ายทอดความรู้ ร้อยละ 80
2.3 เพิ่มพัฒนาคุณภาพชีวิต และความสุขมวลรวมของประชาชนในพื้นที่ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ		2.3 ผู้สูงอายุมีแกนนำทางด้านสุขภาพ 3 กลุ่ม
		2.4 ชุมชนได้รับการพัฒนาเป็นชุมชน



Signature

วัตถุประสงค์ (Objectives)	ผลลัพธ์หลัก (Key results)	ค่าเป้าหมาย
		ต้นแบบการเฝ้าระวัง ภาวะสมองเสื่อม 1 ชุมชน 2.5 นวัตกรรมป้องกัน สมองเสื่อม จำนวน 1 นวัตกรรม 2.4 “สถานีประเมิน สุขภาพจิต” Mental Health Screening Station จำนวน 2 แห่ง 2.5 ยาดมสมุนไพรคลาย เครียด 1 ภูมิปัญญา 2.6 จำนวนการมีส่วนร่วม ของชุมชนจำนวน 1 ชุมชน 2.7 ประชาชนมี GVH เพิ่มขึ้นจากเดิม ร้อยละ 10 2.8 ประชาชนมีคุณภาพ ชีวิตเพิ่มขึ้นในระดับดี

7. ขอบเขตการจัดโครงการ

กิจกรรม	สถานที่/กลุ่มเป้าหมาย	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเดือนและไตรมาส)	งบประมาณ (บาท)
กิจกรรมที่ 1 คัดกรองและ ประเมินความเสี่ยงภาวะ สมองเสื่อมในชุมชน ร่วมกับทักษะวิศวกรสังคม	1. สถานที่ : ชุมชนในเขตตำบล นาฝาย/มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 2. วิทยากร/คณะทำงาน 5 คน 3. กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษา 45 คน ผู้สูงอายุ 100 คน	กุมภาพันธ์ - สิงหาคม 2569 ไตรมาส 2-4	35,200
กิจกรรมที่ 2 อบรมความรู้ รอบเรื่องการดูแลสุขภาพ สมองและการป้องกัน ภาวะสมองเสื่อมในชุมชน	1. สถานที่: มหาวิทยาลัยราชภัฏ ชัยภูมิ/ตำบลนาฝาย 2. วิทยากร /คณะทำงาน 8 คน กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษา 50 คน ผู้สูงอายุ 62 คน	กุมภาพันธ์ - สิงหาคม 2569 ไตรมาส 2-4	64,800



8. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน

กิจกรรม	วิธีการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดกิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 คัดกรองและประเมินความเสี่ยงภาวะสมองเสื่อมในชุมชนร่วมกับทักษะวิศวกรสังคม	1.1 ดำเนินการประสานวิทยากรอบรมทักษะวิศวกรสังคมและการประเมินความเสี่ยงภาวะสมองเสื่อม 1.2 จัดอบรมทักษะวิศวกรสังคมและการประเมินความเสี่ยงภาวะสมองเสื่อม เพื่อเตรียมความพร้อมในการคัดกรองและประเมินความเสี่ยงภาวะสมองเสื่อมในชุมชนร่วมกับทักษะวิศวกรสังคม 1.3 ประสานผู้นำชุมชน เพื่อวางแผนในการลงพื้นที่คัดกรองและประเมินความเสี่ยงภาวะสมองเสื่อมในชุมชน 1.4 ดำเนินกิจกรรมคัดกรองและประเมินความเสี่ยงในชุมชน 1.5 สรุปผลการคัดกรองภาวะสมองเสื่อมในชุมชน เพื่อเตรียมชุมชนในกิจกรรมที่ 2 การอบรมความรู้รอบเรื่องการดูแลสุขภาพสมองและการป้องกันภาวะสมองเสื่อมในชุมชน	1.1 ผู้เข้าร่วมโครงการ 150 คน 1.2 นักศึกษาสาขาสาธารณสุขศาสตร์มีทักษะด้านการคัดกรองและประเมินสุขภาพสูงอายุในชุมชนทางเพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 1.3 นักศึกษาสาขาสาธารณสุขศาสตร์มีทักษะด้านทักษะวิศวกร ร้อยละ 80 1.4 ผู้สูงอายุในชุมชนได้รับการคัดกรองสมรรถภาพการทำงานของสมองและประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะสมองเสื่อม ร้อยละ 80
กิจกรรมที่ 2 อบรมความรู้รอบเรื่องการดูแลสุขภาพสมองและการป้องกันภาวะสมองเสื่อมในชุมชน	2.1 ดำเนินการประสานวิทยากรอบรมความรู้รอบเรื่องการดูแลสุขภาพสมองและการป้องกันภาวะสมองเสื่อมในชุมชน 2.2 ประเมินผลการอบรม คุณภาพชีวิต และความสุขมวลรวมก่อนอบรมฯ 2.3 จัดอบรมความรู้รอบเรื่องการดูแลสุขภาพสมองและการป้องกันภาวะสมองเสื่อมในชุมชนร่วมกับนักศึกษา 2.4 พัฒนาทักษะผู้สูงอายุให้เป็นแกนนำด้านสุขภาพ ในการดำเนินกิจกรรมทางกายเพื่อชะลอภาวะด้านสมองเสื่อมในชุมชนร่วมกับนักศึกษา 2.5 แกนนำผู้สูงอายุ , เครือข่าย, นักศึกษา ร่วมกันพัฒนานวัตกรรมป้องกันสมองเสื่อม 2.4 ประเมินผลการอบรม คุณภาพชีวิต และความสุขมวลรวม หลังอบรมฯ 2.5 สรุปผลและติดตามผลการนำไปใช้ในชุมชน	2.1 ผู้เข้าร่วมโครงการ 120 คน 2.2 นักศึกษามีองค์ความรู้เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการทำงานของสมอง ร่วมกับปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดภาวะสมองเสื่อม ร้อยละ 80 2.3 นักศึกษาสามารถเป็นผู้นำทางด้านสุขภาพด้านการสื่อสารและถ่ายทอดความรู้ ร้อยละ 80 2.4 ผู้สูงอายุมีแกนนำทางด้านสุขภาพ 2.4 ชุมชนได้รับการพัฒนาเป็นชุมชนต้นแบบการเฝ้าระวังภาวะสมองเสื่อม 1 ชุมชน 2.5 นวัตกรรมป้องกันสมองเสื่อม จำนวน 1 นวัตกรรม 2.6 ยาดมสมุนไพรคลายเครียด 1 ภูมิปัญญา 2.7 จำนวนการเครือข่ายร่วมพัฒนาจำนวน 1 เครือข่าย ประชาชนมี GVH เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 10 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตเพิ่มขึ้นอยู่ในระดับดี



9. งบประมาณและรายละเอียดการใช้จ่าย

งบประมาณแผ่นดิน จำนวน 100,000 บาท (-หนึ่งแสนบาทถ้วน-)

กิจกรรม/หมวดงบ	งบประมาณ (บาท)	รายการใช้งบประมาณ
กิจกรรมที่ 1 คัดกรองและประเมินความเสี่ยง ภาวะสมองเสื่อมในชุมชนร่วมกับทักษะ วิศวกรสังคม	35,200	
งบดำเนินงาน	35,200	
1. ค่าตอบแทน	3,600	- ค่าตอบแทนวิทยากร
2. ค่าใช้สอย	25,500	- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม / ค่าอาหารกลางวัน
3. ค่าวัสดุ	6,100	- ค่าวัสดุประกอบการจัดกิจกรรม
กิจกรรมที่ 2 อบรมความรู้รอบเรื่องการดูแล สุขภาพสมองและการป้องกันภาวะสมอง เสื่อมในชุมชน	64,800	
งบดำเนินงาน	64,800	
1. ค่าตอบแทน	21,600	- ค่าตอบแทนวิทยากร
2. ค่าใช้สอย	40,800	- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม / ค่าอาหารกลางวัน
3. ค่าวัสดุ	2,400	- ค่าวัสดุประกอบการจัดกิจกรรม
รวม	100,000	หนึ่งแสนบาทถ้วน

หมายเหตุ : 1. สามารถถัวเฉลี่ยทุกรายการภายใต้กิจกรรมเดียวกัน

2. ทั้งนี้การเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเกณฑ์การเบิกจ่ายที่กระทรวงการคลังกำหนดและเป็นไปตามเกณฑ์การเบิกจ่ายที่มหาวิทยาลัย

กำหนด

10. ผลกระทบ (Impact)

ด้าน	รายละเอียดผลกระทบ
1) ด้านเศรษฐกิจ (Economic)	1. ลดการค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพในระยะยาวการเฝ้าระวังและคัดกรองภาวะสมองเสื่อมตั้งแต่ระยะเริ่มต้นช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ลดการเข้ารับบริการในสถานพยาบาลระดับสูง และลดภาระงบประมาณด้านสาธารณสุขของรัฐและท้องถิ่น 2. สนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนและความเข้มแข็งของสังคมสูงวัยการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนอย่างต่อเนื่องช่วยลดการพึ่งพาบริการดูแลระยะยาวเชิงสถาบัน และส่งเสริมระบบการดูแลที่ยั่งยืนในระดับพื้นที่
2) ด้านสังคม (Social)	1. เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวในการดูแลผู้สูงอายุครอบครัวมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการเฝ้าระวังและคัดกรองภาวะสมองเสื่อมอย่างเหมาะสม ลดความเครียดและความขัดแย้งภายในครอบครัว



ด้าน	รายละเอียดผลกระทบ
	2. สนับสนุนบทบาทมหาวิทยาลัยในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนโครงการสะท้อนบทบาทของมหาวิทยาลัยในการบูรณาการองค์ความรู้กับการทำงานร่วมกับชุมชน ก่อให้เกิดการพัฒนาสังคมผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบและยั่งยืน 3. ชุมชนและประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิต และความสุขมวลรวมเพิ่มขึ้นจากเดิม
3) ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment)	1. ส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อผู้สูงอายุในชุมชนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้สูงอายุช่วยกระตุ้นการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย เป็นมิตร และเหมาะสมกับสังคมผู้สูงอายุ เช่น การจัดพื้นที่กิจกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพกายและใจ
4) ด้านการศึกษา (Education)	1. บูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการแก่สังคมโครงการเปิดโอกาสให้อาจารย์และนักศึกษาได้นำองค์ความรู้ทางวิชาการไปประยุกต์ใช้จริงในชุมชน ส่งเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง (Experiential Learning) 2. พัฒนาทักษะวิชาชีพและสมรรถนะของนักศึกษานักศึกษาได้รับการฝึกทักษะด้านการทำงานร่วมกับชุมชน การสื่อสารสุขภาพ การเฝ้าระวังและคัดกรองภาวะสมองเสื่อม ซึ่งสอดคล้องกับสมรรถนะบัณฑิตและความต้องการของสังคมสูงวัย
5) ด้านบริหารจัดการ (Management)	1. พัฒนาระบบการทำงานแบบบูรณาการระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชนโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือระหว่างคณะ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และเครือข่ายชุมชนเกิดกลไกการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 2. เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารจัดการสุขภาพชุมชน บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องได้รับการพัฒนาทักษะด้านการจัดการโครงการ การทำงานเป็นทีม และการใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจเชิงบริหาร

11. การติดตามและประเมินผล

11.1 การวัดผลความคุ้มค่าของการลงทุนทางสังคม (Social Return on Investment:SROI)

11.2 รายงานผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเป็นข้อมูลผลการดำเนินงานเสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยสภามหาวิทยาลัยทปอ.สำนักงานงบประมาณ และเสนอต่อองค์กรมนตรี

12. ผู้รับผิดชอบโครงการ

12.1 อาจารย์ ดร.วราวุฒิ มหามิตร	ตำแหน่ง อาจารย์	เบอร์โทร 061-9299689
12.2 อาจารย์ปาริชาติ ปากขำนิ	ตำแหน่ง อาจารย์	เบอร์โทร 062-4432993
12.3 อาจารย์พวงผกา อุทาโพธิ์	ตำแหน่ง อาจารย์	เบอร์โทร 063-7263906

13. ผู้รับผิดชอบร่วม

13.1 อาจารย์ปัญญาพร พูลบวรรักษ์	ตำแหน่ง อาจารย์	เบอร์โทร 083-9453595
13.2 ผศ.ดร.ดวงใจ วิชัย	ตำแหน่ง อาจารย์	เบอร์โทร 085-8503038
13.3 ผศ.กรรณา จันทุม	ตำแหน่ง อาจารย์	เบอร์โทร 089-4226252
13.4 อาจารย์สุวิตรา สร้างนา	ตำแหน่ง อาจารย์	เบอร์โทร 086-8619096



[Handwritten signature]

รายละเอียดตัวคูณงบประมาณ
โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
โครงการเฝ้าระวังภาวะสมองเสื่อมแบบมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน

ลำดับ ที่	รายการงบประมาณ/กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย		ระยะเวลา		งบประมาณ		จำนวนครั้ง		รวมทั้งสิ้น (บาท)
		จำนวน	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยนับ	เงิน	บาท	จำนวน	ครั้ง	
	โครงการเฝ้าระวังภาวะสมองเสื่อมแบบมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน									100,000
1	กิจกรรมที่ 1 : คัดกรองและประเมินความเสี่ยงภาวะสมองเสื่อมในชุมชนร่วมกับทักษะวิศวกรสังคม									35,200
	- ค่าตอบแทนวิทยากร	1	คน	6	ชม.	600	บาท	1	วัน	3,600
	- ค่าอาหารว่าง	150	คน	2	มื้อ	35	บาท	1	ครั้ง	10,500
	- ค่าอาหารกลางวัน	150	คน	1	มื้อ	100	บาท	1	วัน	15,000
	- ค่าวัสดุประกอบการจัดกิจกรรม	1	ครั้ง	1	ครั้ง	6,100	บาท	1	ครั้ง	6,100
2	กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมอบรมความรู้รอบเรื่องการดูแลสุขภาพ									64,800
	- ค่าตอบแทนวิทยากร	3	คน	6	ชม.	600	บาท	2	วัน	21,600
	- ค่าอาหารว่าง	120	คน	2	มื้อ	35	บาท	2	วัน	16,800
	- ค่าอาหารกลางวัน	120	คน	1	มื้อ	100	บาท	2	วัน	24,000
	- ค่าวัสดุประกอบการจัดกิจกรรม	1	ครั้ง			2,400	บาท	1	ครั้ง	2,400
	รวมทั้งสิ้น									100,000



[Handwritten signature in blue ink]